

मानव_शरीरको_अङ्ग_प्रत्यारोपण_(नियमिति_तथा_नषिध)_ऐन_२०५५

English title: Human Body Organ Transplantation (Regulation and Prohibition) Act, 1998

मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमिति तथा नषिध) ऐन, २०५५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५५ । १ । २१ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २. मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमिति तथा नषिध) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । २०५५ सालको ऐन नं. २० । मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अनुसार व्यवस्थित रुपमा रोगको उपचार गर्ने प्रयोजनको लागि मानव शरीरबाट अङ्ग झिकिने तथा एक मानवको शरीरबाट अङ्ग झिकी अर्को मानवको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्ने सम्बन्धी कृयाकलापलाई नियमिति गर्ने तथा मानव शरीरको अङ्ग खरदि बकिरी तथा अन्य कार्यमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कृयाकलापलाई नषिध गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमिति तथा नषिध) ऐन, २०५५” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “मानव शरीर” भन्नाले जीवित वा मृत मानवको शरीर सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क१) “मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेन डेथ)” भन्नाले मस्तिष्क स्टेम (ब्रेन स्टेम) को मृत्यु सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मस्तिष्कको ग्रहण गर्ने (रसिप्टिभि) र प्रतिक्रिया दिने (रेस्पान्सिभि) क्रियाकलापमा अप्रत्यावर्तनीय क्षति भएको अवस्थालाई समेत जनाउँछ । स्पष्टीकरण : “मस्तिष्क स्टेम (ब्रेन स्टेम)” भन्नाले सेरेब्रम र स्पाइनल कर्डलाई जोड्ने बीचको मडि ब्रेन, पन्स र मेडुला अबलङ्गेटा सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क२) “अप्रत्यावर्तनीय क्षति (इरभिरसबिल ड्यामेज)” भन्नाले मस्तिष्कको क्रियाकलाप पुनः काममा आउन नसक्ने गरी पूर्ण रुपमा क्षति भएको अवस्था सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क३) “मन्त्रालय” भन्नाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ख) “अङ्ग” भन्नाले मानव शरीरको कुनै अङ्ग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मानव शरीरका तन्तु (टसियु) समेतलाई जनाउँछ । (ग) “अङ्ग प्रत्यारोपण” भन्नाले आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अनुसार व्यवस्थित रुपमा रोगको उपचार गर्ने प्रयोजनको लागि एक मानव शरीरको अङ्ग अर्को मानव शरीरमा प्रत्यारोपण गरिने कार्य सम्झनु पर्छ । (घ) “अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप” भन्नाले आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अनुसार व्यवस्थित रुपमा रोगको उपचार गर्ने प्रयोजनको लागि मानव शरीरबाट अङ्ग झिकिने, त्यसरी झिकिएको अङ्ग वैज्ञानिक प्रविधि तथा पद्धति अपनाई सुरक्षित कसिमिले सञ्चय गर्ने वा अर्को मानवको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्ने सम्बन्धी कृयाकलाप सम्झनु पर्छ । (ङ) “स्वास्थ्य संस्था” भन्नाले यस ऐन बमोजिम अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमतपित्र प्राप्त स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ ।

(च) “अनुमतपित्र” भन्नाले अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप सञ्चालन गर्न दफा ५ बमोजिम दिइने अनुमतपित्र सम्झनु पर्छ । (छ) “व्यक्तिगत इजाजतपत्र” भन्नाले अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप गर्न दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम दिइने व्यक्तिगत इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ । (ज) “चिकित्सक” भन्नाले दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता प्राप्त चिकित्सक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १२छ. बमोजिमको चिकित्सकको टोलीलाई समेत जनाउँछ । (झ) “समिति” भन्नाले दफा १२ बमोजिम गठित अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समिति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ञ) “दाता” भन्नाले अङ्ग दान गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले मृतकको हकमा त्यस्तो मृतकको अङ्ग दान गर्ने नजिको परिवारको सदस्यलाई समेत जनाउँछ । स्पष्टीकरण : “परिवारको सदस्य” भन्नाले प्राथमिकताक्रम अनुसार क्रमशः पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, दाजु, भाई, दादी, बहनी, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, सासु, ससुरा सम्झनु पर्छ । (ट) “अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्ति” भन्नाले यस ऐन बमोजिम दाताले दान गरेको अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ठ) “नजिकको नातेदार” भन्नाले अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने बाबु आमा, सौतेनी बाबु, सौतेनी आमा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, दाजु, भाई, दादी, बहनी, ठूलोबुबा, ठूलीआमा, काका, काकी, सानोबाबु, सानीआमा, भतजा, भतजी, सासु, ससुरा, जेठाजु, जेठानी, देउरानी, नन्द, देवर, भाउजु, बुहारी, मामा, माइजु, भान्जा, भान्जी, साला, साली, फुपू, फूपाजू, आमाजू, भदा, भदै, भनाजू, ज्वाइँ, जेठान सम्झनु पर्छ । तर धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने बाबुआमा र वैवाहिक सम्बन्धबाट कायम भएको नाता सम्बन्धको हकमा कम्तीमा दुई वर्षदेखि अटुट रुपमा नाता सम्बन्ध कायम रहिआएको हुनु पर्नेछ । (ड) “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी अनुमतपित्र तथा व्यक्तिगत इजाजतपत्र । ३. अनुमतपित्र नलिई अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप सञ्चालन गर्न नहुने : यस ऐन बमोजिम अनुमतपित्र नलिई

कसैले पनअड्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप सञ्चालन गर्न गराउन हुँदैन । ४. अनुमतपत्रको लागि दरखास्त दनि : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएको सरकारी अस्पतालले बाहेक अरूले अड्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप सञ्चालन गर्न तोकिएको दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अनुमतपत्रको लागि समिति समक्ष दरखास्त दनु पर्नेछ । ५. अनुमतपत्र दनि : (१) दफा ४ बमोजिम दरखास्त परेमा समितिले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी दरखास्तवालालाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अनुमतपत्र दनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतपत्र प्राप्त गर्नको लागि सम्बन्धित दरखास्तवालाले व्यवस्था गर्नु पर्ने भौतिक साधन, जनशक्ति तथा अन्य आवश्यक सुविधाहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

६. व्यक्तित्व इजाजतपत्र नलिई अड्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप गर्न नहुने : यस ऐन बमोजिम व्यक्तित्व इजाजतपत्र नलिई कसैले पनअड्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप गर्नु हुँदैन । ७. व्यक्तित्व इजाजतपत्रको लागि दरखास्त दनि : अड्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप गर्न चाहने चिकित्सकले तोकिएको दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा व्यक्तित्व इजाजतपत्रको लागि समिति समक्ष दरखास्त दनु पर्नेछ । ८. व्यक्तित्व इजाजतपत्र दनि : (१) दफा ७ बमोजिम दरखास्त परेमा समितिले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी दरखास्तवालालाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा व्यक्तित्व इजाजतपत्र दनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम व्यक्तित्व इजाजतपत्र लिनको लागि चिकित्सकले प्राप्त गर्नु पर्ने योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । ९. अनुमतपत्रको अवधि र नवीकरण : (१) अनुमतपत्रको अवधि दफा १० बमोजिम अगावै खारेज भएमा बाहेक अनुमतपत्र दिएको मितिले दुई वर्षसम्म कायम रहनेछ । (२) अनुमतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अनुमतपत्र नवीकरणको लागि समिति समक्ष दरखास्त दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दरखास्त परेपछि समितिले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी प्रत्येक पटक दुई वर्षसम्मका लागि अनुमतपत्रको अवधि नवीकरण गरिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम नवीकरण नगराएको अनुमतपत्र स्वतः खारेज हुनेछ । १०. अनुमतपत्र तथा व्यक्तित्व इजाजतपत्रको खारेजी तथा नलिम्बन : (१) स्वास्थ्य संस्था तथा व्यक्तित्व इजाजतपत्र प्राप्त चिकित्सकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम गरेमा वा दफा २९ बमोजिम समितिले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालना नगरेमा समितिले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको अनुमतपत्र तथा चिकित्सकको व्यक्तित्व इजाजतपत्र छ महिनासम्मको लागि नलिम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतपत्र वा व्यक्तित्व इजाजतपत्र नलिम्बन वा खारेज गर्नु अगावै समितिले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा चिकित्सकलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मुनासबि माफिकको मौका दनु पर्नेछ । ११. पुनरावेदन : (१) दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम समितिले दिएको आदेश उपर चर्चित नबुझ्ने स्वास्थ्य संस्था वा चिकित्सकले त्यस्तो आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको पुनरावेदनको सम्बन्धमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । परिच्छेद-३ । अड्ग प्रत्यारोपण समन्वय समिति । १२. अड्ग प्रत्यारोपण समन्वय समिति : (१) यस ऐनमा लेखिएका अन्य काम, कर्तव्य तथा अधिकारका अतिरिक्त अड्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धमा नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारमा पेश गर्नको लागि देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु भएको एक अड्ग प्रत्यारोपण समन्वय समिति गठन हुनेछ :- ।

(क) नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको वरिष्ठ चिकित्सक — अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारबाट मनोनीत चिकित्सक तीनजना — सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) प्रतनिधि, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह मन्त्रालय — सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) प्रतनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय — सदस्य । (ङ) प्रतनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल — सदस्य । (च) प्रतनिधि, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन — सदस्य । (छ) महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग — सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मनोनीत अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजिहरु पुनः मनोनयन हुन सक्नेछन् । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (४) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (५) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) समितिका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (७) समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (८) समितिको सचिवालय नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवा विभागमा रहनेछ । परिच्छेद-३क । मस्तिष्क मृत्यु सम्बन्धी । १२क. स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्ने : चिकित्सकले दफा १२ख. को प्रयोजनको लागि कुनै बरिमीको परीक्षण गर्नु अघि त्यस्तो बरिमीको तोकिए बमोजिम प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्नेछ । १२ख. मस्तिष्कको पूर्ण क्षति भए नभएको अवस्था यकिन गर्नको लागि परीक्षण गर्न सक्ने : (१) चिकित्सकले कुनै बरिमीमा देहायको अवस्था वदियमान भएमा मात्र त्यस्ता बरिमीको मस्तिष्कको पूर्ण क्षति भए वा नभएको अवस्था यकिन गर्नको लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्नेछ :- । (क) अप्रत्यावर्तनीय क्षति भएको, । (ख) मस्तिष्क स्टेममा कुनै प्रतिक्रिया नभएको, । (ग) बरिमीको शरीरमा प्राकृतिक रुपमा श्वास प्रश्वास नभएको । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि चिकित्सकले बरिमीको परिवारको कुनै सदस्यको लखित सहमत लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्ने बरिमीको

परिवारको कुनै सदस्य उपलब्ध नभएमा वा पहिलो संशोधनद्वारा थप । वेवारसि बरिमीको हकमा चिकित्सकले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधिको रोहबरमा बरिमीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखबाट गरिने भएमा सो स्वास्थ्य संस्थाका अन्य वरिष्ठ चिकित्सकलाई उपदफा (३) बमोजमि रोहबरमा राख्नु पर्नेछ ।

(५) चिकित्सकले उपदफा (१) बमोजमि गरेको स्वास्थ्य परीक्षणबाट बरिमीको मस्तिष्कको अप्रत्यावर्तनीय क्षति भएको, मस्तिष्क स्टेममा प्रतिक्रिया नभएको तथा बरिमीको शरीरमा प्राकृतिक रुपमा श्वास प्रश्वास भएको नदेखिएमा मस्तिष्क मृत्यु भएको सुनिश्चित गर्नु त्यसरी स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ घण्टा पछि बरिमीको पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्नेछ । १२ग. स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु नहुने : दफा १२ख. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चिकित्सकले देहायको कुनै अवस्थामा बरिमीको मस्तिष्कको पूर्ण क्षति भए वा नभएको अवस्था यकिन गर्नुको लागि बरिमीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु हुँदैन :- (क) रोगको नदिन नभएको, । (ख) बरिमीको शरीरमा न्यूनतम तापक्रम पैतीस डिग्री सेल्सियस भन्दा कम भएको, । (ग) बरिमीको शरीरमा न्यूनतम रक्तचाप (सिस्टोलिक नब्बे मलिमिटर मर्करीभन्दा कम) भएको, । (घ) बरिमीको आन्तरिक गर्न्थीमा असन्तुलन भएको, । (ङ) बरिमी लट्ठ पार्ने औषधिको प्रयोगबाट मुच्ची परेको । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "लट्ठ पार्ने औषधि" भन्नाले लागू औषधि, नदिरा लगाउने औषधि, अचेत पार्ने औषधि वा मांसपेशी लठ्याउने औषधि समझनु पर्छ । १२घ. मस्तिष्क मृत्युको घोषणा गर्ने : (१) दफा १२ख. को उपदफा (५) बमोजमि गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट समेत बरिमीको मस्तिष्कको मृत्यु भएको देखिएमा चिकित्सकले त्यस्तो बरिमीको मस्तिष्क मृत्यु भएको घोषणा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मस्तिष्क मृत्यु भएको घोषणा गरिसकेपछि त्यस्तो बरिमीको मृत्यु भएको मानिन्छ । (३) मस्तिष्क मृत्युको घोषणा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२ङ. मस्तिष्क मृत्युको जानकारी गराउनु पर्ने : (१) दफा १२घ. बमोजमि मस्तिष्क मृत्युको घोषणा गर्नु अघि चिकित्सकले बरिमीको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी यथार्थ वविरण सहित बरिमीको मस्तिष्क मृत्यु भएको जानकारी नजिको परिवारका सदस्यलाई गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बरिमीको परिवारको सदस्य उपलब्ध नभएको वा वेवारसि बरिमीको हकमा चिकित्सकले दफा १२घ. बमोजमि बरिमीको मस्तिष्क मृत्युको घोषणा गरी सो को जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मन्त्रालयलाई गराउनु पर्नेछ । १२च. चिकित्सकको योग्यता : देहाय बमोजमिको योग्यता भएको चिकित्सक मात्र मस्तिष्क मृत्युको घोषणा गर्ने काममा संलग्न हुन सक्नेछ :- (क) चिकित्सा विज्ञानमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, । (ख) नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा विशेषज्ञ चिकित्सकको रुपमा स्थायी दर्ता भएको, । (ग) नेपाली नागरिक ।

१२छ. चिकित्सकको टोलीद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने : यस परिच्छेद बमोजमि बरिमीको स्वास्थ्य परीक्षण तथा बरिमीको मस्तिष्क मृत्युको घोषणा गर्दा दफा १२च. बमोजमि योग्यता पुगेका चिकित्सकहरुमध्ये बरिमीको उपचारमा संलग्न बरिमीको रोगसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक सहित कम्तीमा एकजना एनेस्थेसियोलोजिस्ट वा इन्टेन्सिभिस्ट रहेको चिकित्सकको टोलीबाट गर्नु पर्नेछ । १२ज. स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्ने पूर्वाधार : तोकिए बमोजमिका पूर्वाधार भएका स्वास्थ्य संस्थामा मात्र दफा १२क. र १२ख. बमोजमि बरिमीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिन्छ । १२झ. मस्तिष्क मृत्युको घोषणा गर्न वा अङ्ग प्रत्यारोपणको कार्यमा संलग्न हुन नपाउने : यस ऐन बमोजमि अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न शल्य चिकित्सक मस्तिष्क मृत्युको घोषणा गर्ने कार्यमा र मस्तिष्क मृत्युको घोषणा गर्ने चिकित्सक अङ्ग प्रत्यारोपणको कार्यमा संलग्न हुन पाउने छैन । परिच्छेद-४ । अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप । १३. अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप गर्न नहुने : अङ्ग खरदि बकिरी गर्ने वा त्यस्तै प्रकारका अन्य कामको प्रयोजनको लागि अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप गर्नु हुँदैन । १४. अङ्ग झकिन् तथा अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न सकिने : यस ऐनमा लेखिएका अन्य व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अनुसार व्यवस्थित रुपमा रोगको उपचार गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र मानव शरीरबाट अङ्ग झकिन् र एक मानव शरीरबाट अङ्ग झिकी अर्को मानव शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १४क. अङ्ग दान दिनु सक्ने : (१) देहायको व्यक्तिले बरिमीलाई आफ्नो अङ्ग दान दिनु सक्नेछ :- (क) बरिमीको नजिकको नातेदार, । (ख) दुई वा दुईभन्दा बढी परिवारका कुनै सदस्यलाई अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यस्ता परिवारका आफ्नो नजिकको नातेदारको अङ्ग नमाली प्रत्यारोपण हुन नसक्ने अवस्था भएमा र त्यसरी प्रत्यारोपण गर्न खोजिएको अङ्ग अर्को परिवारको सदस्यसँग मिल्ने भएमा आपसी सहमतको आधारमा लखित रुपमा एक अर्काको परिवारको सदस्यले । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिको अवस्थामा अङ्ग दान दिनु वा अङ्ग ग्रहण गर्न चाहने व्यक्तिले सो व्यहोरा खोली स्वीकृतको लागि तोकिए बमोजमिको समतिसमक्ष तोकिए बमोजमिको ढाँचामा नविदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त भएको नविदनको व्यहोरा जाँचबुझ गर्दा मनासबि देखिएमा सो समतिले सम्बन्धित व्यक्तिलेलाई अङ्ग दान वा अङ्ग ग्रहण गर्न स्वीकृत दिनु सक्नेछ । (४) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने कार्य समानान्तर रुपमा शल्यचिकित्सा गरी एकै पटक गर्नु पर्नेछ । १५. जीवित व्यक्तिको शरीरबाट अङ्ग झकिन् सक्ने : (१) यस ऐनमा लेखिएका अन्य व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही देहायको

अवस्थामा मात्र जीवति व्यक्ती (दाता) को शरीरबाट अङ्ग झिकी त्यस्तो अङ्ग पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । सम्बन्धति बरिमीको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ ।

(क) कुनै बरिमीको शरीरको कुनै अङ्ग काम नलाग्ने गरी नासिएको छ र त्यस्तो बरिमीको जीवन रक्षाको लागि निजिको शरीरको नासिएको अङ्गको सट्टा अर्को अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न आवश्यक छ भनी कम्तीमा दुई जना सम्बन्धति चिकित्सकहरुले प्रमाणति गरदिएको, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको बरिमीलाई दाताले आफ्नो नजिकिको नातेदारको सहमति सहति स्वेच्छाले अङ्ग दान गर्न लखिति मज्जुरी दिएको, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि स्वेच्छाले अङ्ग दान गर्न मज्जुरी दनि दाता अठार वर्ष उमेर पूरा भएको, । (घ) खण्ड (ख) बमोजमि मज्जुरी दनि दाताको शरीरको जोडी अङ्ग मध्ये कुनै एक अङ्ग झिकिदा दाता त्यसैको कारणले तत्कालै नमर्ने र स्थायी रुपबाट अशक्त वा अपाङ्ग नहुने भनी कम्तीमा दुईजना सम्बन्धति चिकित्सकहरुले प्रमाणति गरदिएको, । (ङ) दाताको शरीरबाट झकिन् खोजिएको तन्तु पुनर्विकास हुन सक्ने भनी कम्तीमा दुईजना सम्बन्धति चिकित्सकहरुले प्रमाणति गरदिएको । (२) यस ऐनमा लेखिएका अन्य व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही अठार वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्तिको शरीरमा कुनै तन्तु पुनर्विकास हुन सक्ने भनी कम्तीमा दुईजना सम्बन्धति चिकित्सकहरुले प्रमाणति गरदिनेमा त्यस्तो व्यक्तिको शरीरबाट उक्त तन्तु झकिन् यस दफाले कुनै बाधा पुर्याएको माननि छैन । (३) कुनै व्यक्तिको उपचारको सलिसलामा नजिको शरीरमा रहेको काम नलाग्ने अङ्ग झकिर फयाक्न यस दफाले कुनै बाधा पुर्याएको माननि छैन । (४) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि सहमति तथा मज्जुरी दनि सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि दिएको मज्जुरी दाताले चाहेमा फर्ति लनि सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि दाताले मज्जुरी फर्ति लनेमा अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिले दाता उपर कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन । १६. मृत व्यक्तिको शरीरबाट अङ्ग झकिन् सकिने : (१) यस ऐनमा लेखिएका अन्य व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही देहायको अवस्थामा मात्र कुनै मृत व्यक्तिको शरीरबाट अङ्ग झकिन् वा त्यसरी झकिएको अङ्ग अन्य कुनै व्यक्तिको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ :- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (क) जुन व्यक्तिको शरीरबाट अङ्ग झकिने हो सो व्यक्तिको मस्तषिक मृत्यु भइसकेको सम्बन्धति चिकित्सकले घोषणा गरेको, । (ख) मृत्यु पश्चात् दफा १४ को प्रयोजनको लागि आफ्नो अङ्ग दान गर्न चाहने व्यक्तिले जानीबुझी स्वेच्छाले लखिति मज्जुरी दिएको, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि मज्जुरी नभएको अवस्थामा मृतकको परिवारको कुनै सदस्यले मृतकको शरीरको अङ्ग दान गर्न लखिति मज्जुरी दिएको । तर मृतकले जीवति छँदै आफ्नो शरीरको अङ्ग दान नगर्ने लखिति रुपमा इच्छा व्यक्त गरेको भए परिवारको सदस्यले त्यस्तो मृतकको शरीरको अङ्ग दान गर्न सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) को खण्ड पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ख) र (ग) बमोजमि मज्जुरी दनि सम्बन्धी अन्य कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

१६क. शव परीक्षण गर्नु अघि अङ्ग झकिन् सक्ने : प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मृतकको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको कुरामा तोकिए बमोजमिको समति विश्वस्त भएमा सो समतिको स्वीकृतिमा मृतकको शव परीक्षण गर्नु अघि निजिको शरीरबाट अङ्ग झकिन् सकिन्छ । १७. मृत व्यक्तिको शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न नहुने : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दफा १६ वा १६क. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि किरतव्य वा आत्महत्याद्वारा वा शङ्कास्पद अवस्थामा मृत्यु भएको व्यक्तिको शव परीक्षणमा असर पर्न सक्ने गरी कुनै पनि मृत व्यक्तिको शरीरबाट अङ्ग झिकी अर्को मानव शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न हुँदैन । तर त्यस्तो मृत व्यक्तिको शव परीक्षण वा अन्य कुनै अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि अङ्ग झकिन् यस दफाले कुनै बाधा पुर्याएको माननि छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७क. प्राथमकिताको सूची बनाउनु पर्ने : स्वास्थ्य संस्थाले मृतकको शरीरबाट झकिएको अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने प्रयोजनको लागि अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको तोकिए बमोजमि प्राथमकिताक्रमको सूची बनाई अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७ख. समन्वय इकाई तोकने : (१) दफा १२घ. बमोजमि मस्तषिक मृत्युको घोषणा भएका व्यक्तिको अङ्ग झकिने, झकिंका अङ्गलाई सुरक्षति रुपमा राख्ने, अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने व्यक्तिको अभिलेख दुरुस्त राख्ने तथा प्राप्त अङ्गलाई तोकिए बमोजमिको प्राथमकिताक्रम अनुसार वतिरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समन्वय इकाई तोकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समन्वय इकाई नतोकिसम्म मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुरले समन्वय इकाईको काम गर्नेछ । (३) कुनै अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रको दफा १२घ. बमोजमि कुनै व्यक्तिको मस्तषिक मृत्युको घोषणा गरेमा समन्वय इकाईलाई तुरुन्त जानकारी गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको जानकारी प्राप्त हुन आएमा समन्वय इकाईले सम्बन्धति स्वास्थ्य संस्थासँग अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नको लागि समन्वय गर्नु पर्नेछ । (५) मस्तषिक मृत्युको घोषणा गर्ने सम्बन्धति अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रले समन्वय इकाईलाई अङ्ग झकिने व्यवस्थाको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक सुविधा तथा जनशक्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) समन्वय इकाईको अन्य कार्य तोकिए बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७ग. रकम उपलब्ध गराउन सक्ने : दफा १२घ. बमोजमि मस्तषिक मृत्युको घोषणा भएका व्यक्तिको अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी क्रियाकलाप भए पश्चात् मस्तषिक मृत्युको घोषणा गर्ने अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र, अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने स्वास्थ्य संस्था र मस्तषिक मृत्यु घोषणा भएको व्यक्तिको परिवारको सदस्यलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजमिको रकम उपलब्ध

गराउन सक्नेछ ।

१८. सम्भावित खतराप्रतिसिजग गराउनु पर्ने : यस ऐन बमोजमि चकितिसकले अङ्ग झकिदा तथा अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दा दाता र अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गरी त्यसबाट नजिहटुको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने सम्भावित असर तथा खतराप्रति दुवै पक्षलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । १९. अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको मज्जुरी हुनुपर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दा अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको पनमिज्जुरी हुनु पर्नेछ । (२) अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तीनाबालक तथा नरिण्य गर्न नसक्ने अवस्थाको भएमा त्यस्तो व्यक्तिको तर्फबाट नजिको नजिकिको नातेदारले त्यस्तो मज्जुरी दनि सक्नेछ । २०. मज्जुरी बनि अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न सक्ने : दफा १९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको परिवारका सदस्यको मज्जुरी नभए तापनि अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न सक्नेछ :- । (क) अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्ती बेवारसि भएमा, । (ख) अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको नजिकिको नातेदारलाई उचित समयमा सूचना दिई मज्जुरी लनि नसक्ने भएमा, । (ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजमिको अवस्थामा तत्काल अङ्ग प्रत्यारोपण नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना भएमा । २१. लागत खर्च तथा सेवा शुल्क : स्वास्थ्य संस्थाले यस ऐन बमोजमि अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दा अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई लागत खर्च तथा सेवा शुल्क लनि सक्नेछ । तर, । (क) त्यस्तो सेवा शुल्कको दर समतिबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ । (ख) त्यस्तो सेवा शुल्कको दर समतिलि नरिदेश गरे बमोजमि प्रकाशन गरेको हुनु पर्नेछ । (ग) त्यस्तो सेवा शुल्कको दर उचित र मनासबि हुनु पर्नेछ । २२. अङ्ग झकिदा वा अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रावधिक कुराहरु : यस ऐन बमोजमि अङ्ग झकिदा वा झकिएको अङ्गको सुरक्षित रूपमा संचय गर्दा वा अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दा अपनाउनु पर्ने आधुनिक चकितिसाशास्त्र सम्बन्धी प्रावधिक कुराहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-५ । अपराध र दण्ड सजाय । २३. अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी अपराध : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा १२क., १२ख., १२ग., १२घ., १२ङ., १२च., १२छ., १२ज., १२झ., १३, १४, १५, १६ र १७ मा उल्लिखित व्यवस्था विपरीत हुने गरी कसैले कसैको अङ्ग झकिमा वा त्यसरी झकिएको अङ्ग कसैलाई प्रत्यारोपण गरेमा वा अन्य काममा प्रयोग गरेमा वा त्यस्तो कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएमा यस ऐन बमोजमि अपराध गरेको मानिनेछ । २४. दण्ड सजाय : (१) दफा २३ बमोजमिको अपराध गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) स्वास्थ्य संस्था बाहेक अन्य स्थानमा दफा २३ बमोजमिको अपराध गर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (१) बमोजमि हुने सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) व्यक्तितगत इजाजतपत्र नलिएको व्यक्तिले स्वास्थ्य संस्था बाहेक अन्य स्थानमा दफा २३ बमोजमिको अपराध गरेको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई उपदफा (१) बमोजमि हुने सजायमा थप दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) दफा २३ बमोजमिको अपराध भएको अवस्थामा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । अङ्ग झकिने जीवित व्यक्तीसोही चोट पीरको कारणले तीन महिनाभित्र मरेमा त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको ।

जन्म कैद हुनेछ । (५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा लेखिएदखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित व्यवस्था विपरीत अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । २५. उद्योग गरेमा हुने सजाय : दफा २३ बमोजमिको अपराध गर्नलाई सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको तर अपराध भने हुन नपाएको अवस्थामा त्यस्तो अपराधको उद्योग गरेको मानिनेछ र त्यस्तो उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई दफा २४ बमोजमि हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । २६. मतयारलाई हुने सजाय : दफा २३ बमोजमिको अपराध हुने कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने व्यक्ती बाहेक त्यस्तो अपराध गर्न सहयोग पुर्‍याउने व्यक्तिलाई मतयार मानिनेछ र मतयारलाई अभ्युक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । २७. वजिजापन तथा प्रचार प्रसार गर्न नहुने : (१) अङ्ग उपलब्ध गराउन सक्ने वा अङ्ग आवश्यक भएको भन्ने बारेमा कसैले पनप्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चार माध्यमबाट वजिजापन तथा प्रचार प्रसार गर्न गराउन हुँदैन । तर अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी प्रावधिक ज्ञान दनि दिलाउने उद्देश्यले तत्सम्बन्धी सूचनाहरु प्रवाह गर्न यस दफाले कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । (२) उपदफा (१) विपरीत वजिजापन प्रकाशन गर्ने सञ्चार संस्था, प्रकाशक र सम्पादक तथा प्रसारण गर्ने संस्था र प्रसारकलाई तोकिएको अधिकारीले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको अधिकारीले गरेको जरिवाना उपर चर्चित नबुझनिले त्यस्तो जरिवाना भएको थाहा पाएको मतिलि ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालत समक्ष पुनरावेदन दनि सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विविधि । २८. नरीक्षण : (१) स्वास्थ्य संस्था तथा व्यक्तितगत इजाजतपत्र प्राप्त चकितिसकले अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप सञ्चालन गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा दफा २९ बमोजमि दिइएको आदेश तथा नरिदेशनहरु पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा समतिबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले नरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण गर्ने अधिकारीले आफूले गरेको नरीक्षणको प्रतविदन समति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । २९. आदेश तथा नरिदेशन दनि सक्ने : (१) दफा २८ बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीले नरीक्षण गरेको अवस्थामा वा अन्य जुनसुकै अवस्थामा समतिलि स्वास्थ्य संस्था तथा व्यक्तितगत इजाजतपत्र प्राप्त चकितिसकलाई अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक आदेश तथा नरिदेशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समतिलि आदेश तथा नरिदेशन दिँदा खासगरी देहायको विषयमा दनिनेछ

:- । (क) चिकित्सा शास्त्रको सन्निधान्त अनुसार अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रावधिकि वषियको सम्बन्धमा । (ख) अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दा आवश्यक पर्ने भौतिकि स्रोत साधन तथा जनशक्ति सम्बन्धमा । (ग) अङ्ग प्रत्यारोपणको लागी मानव शरीरबाट झकिपिको अङ्गलाई वैज्ञानिकि प्रवर्धित तथा पद्धतिअपनाई सुरक्षित रूपमा सम्बन्धमा ।

(घ) अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्थाको सम्बन्धमा । (ङ) अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी प्रावधिकि वषियका सूचनाहरू प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा । (३) उपदफा (२) बमोजमि समितिले दिएको आदेश तथा निर्देशनहरूको पालना गर्नु गराउनु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था तथा व्यक्तितगत इजाजतपत्र प्राप्त चिकित्सकको कर्तव्य तथा दायित्व हुनेछ । ३०. बयान दनि कर नलाग्ने : स्वास्थ्य संस्था वा व्यक्तितगत इजाजतपत्र प्राप्त चिकित्सक तथा उक्त संस्था वा चिकित्सकसँग सम्बन्धित व्यक्तितहरूले यस ऐन बमोजमि सञ्चालन गरेको अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृत्याकलापको बारेमा प्रचलित कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बाहेक अन्यत्र कसैलाई बयान दनि कर लाग्ने छैन । ३१. वार्षिकि प्रतविदन : (१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृत्याकलापको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजमि सम्पादन गरेको कामको वविरण तोकिएको ढाँचामा तयार गरी प्रत्येक वर्ष समितिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्वास्थ्य संस्थाले पेश गरेको प्रतविदनको सम्बन्धमा समितिले आफ्नो मूल्याङ्कन र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतितथा कार्यक्रम बारे सुझाव सहितको प्रतविदन प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ३२. नेपाल सरकार वादी हुने : यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दाहरू नेपाल सरकार वादी भई दायर गरनि छन् र ती मुद्दाहरू केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यवधित(संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको माननिछ । ३३. सम्पर्क मन्त्रालय : समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ३४. नयिम बनाउन सक्ने : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ ।